

Psicopatología de la niñez y adolescentes

Profesora: Dra. Aelen López

Trastorno síntomas somáticos

Ponentes: Licenciadas

Jessica morales

y Ibis Arauz



Tabla de Contenido

- 01 Presentación
- 02 Introducción
- 03 Pensamiento o Frase
- 04 Criterios DX.
- 05 Estadísticas Internacional
- 06 Cuadro Comparativo DSM 5 TR. Y CIE 11
- 08 Resumen o investigación del Trastorno
- 09 Famosos que presentan el DX.
- 10 Viedo
- 11 Conclusión



Introducción

El trastorno de síntomas somáticos y sus trastornos relacionados según el DSM-5-TR se caracterizan por una preocupación excesiva hacia los síntomas físicos, lo que genera una angustia significativa y altera el funcionamiento diario del individuo.



Introducción

A diferencia de versiones anteriores del manual, el diagnóstico actual no se basa únicamente en que los síntomas sean "médicamente inexplicables", sino en la reacción psicológica desproporcionada (pensamientos, sentimientos y conductas) que la persona tiene frente a ellos.



PSYCHOLOGY



Frase o Reflexión

"Lo que no se expresa con palabras, se expresa con dolores".

Sigmund Freud.



Criterio del Trastorno Síntoma Somáticos



A. Síntomas Somáticos: Uno o más síntomas somáticos (físicos) que causan malestar o alteran significativamente la vida diaria.

B. Pensamientos /Comportamientos Excesivos: Pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con los síntomas somáticos o asociados a la preocupación por la salud, manifestados por al menos uno de los siguientes:

1. Pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de los síntomas.
2. Nivel persistentemente alto de ansiedad sobre la salud a los síntomas.
3. Dedicación excesiva de tiempo y energía a estos síntomas o preocupaciones de salud.



C. Persistencia

Aunque algún síntoma somático puede no estar continuamente presente, el estado sintomático es persistente (generalmente más de 6 meses)

01

Especificar si:

- ⌘ Con dolor predominante: Los individuos con este especificador tienen un dolor somático persistente.



02

Persistente: Un curso persistente se caracteriza por síntomas graves, alteraciones marcadas y una duración prolongada (más de 6 meses).

Especifique la gravedad actual: Leve: Solo se cumple uno de los síntomas especificados en el Criterio B.
Moderado: Se cumplen dos o más de los síntomas especificados en el Criterio B.
Severo: Se cumplen dos o más de los síntomas especificados en el Criterio B, además hay múltiples quejas somáticas (o un síntoma somático muy grave).



TRASTORNOS RELACIONADOS A SINTOMAS SOMATICOS	CRITERIOS DE DIAGNOSTICOS
Trastorno de ansiedad por enfermedad.	A. Preocupación por tener o adquirir una enfermedad grave. B. Los síntomas somáticos no están presentes o, si los hay, son de intensidad leve. Si hay otra condición médica presente o existe un alto riesgo de desarrollar una condición médica (p. ej., hay antecedentes familiares importantes), la preocupación es claramente excesiva o desproporcionada. C. Hay un alto nivel de ansiedad acerca de la salud y el individuo se alarma fácilmente por su estado de salud personal. D. El individuo realiza comportamientos excesivos relacionados con la salud (p. ej., revisa repetidamente su cuerpo en busca de signos de enfermedad) o exhibe una evitación desadaptativa (p. ej., evita las citas con el médico y los hospitales). E. La preocupación por la enfermedad ha estado presente durante al menos 6 meses, pero la enfermedad específica que se teme puede cambiar durante ese período de tiempo.
Trastorno de síntomas neurológicos funcionales (Desorden de conversión)	A. Uno o más síntomas de alteraciones motoras o sensoriales voluntarias. B. Los hallazgos clínicos proporcionan evidencia de incompatibilidad entre el síntoma y las condiciones neurológicas o médicas reconocidas. C. El síntoma o déficit no se explica mejor por otro trastorno médico o mental. D. El síntoma o déficit causa malestar clínicamente significativo o deterioro social, ocupacional u otras áreas importantes de funcionamiento.

Factores psicológicos que afectan a otras condiciones médicas.

A. Un síntoma o condición médica (que no sea una enfermedad mental) trastorno) está presente.

B. Los factores psicológicos o de comportamiento afectan adversamente la condición médica de una de las siguientes maneras:

1. Los factores han influido en el curso de la condición médica como lo demuestra una estrecha asociación temporal entre los factores psicológicos y el desarrollo o exacerbación o retraso en la recuperación de la afección médica.
2. Los factores interfieren en el tratamiento del médico.
3. Los factores influyen en la fisiopatología subyacente, precipitando o exacerbando los síntomas o necesitando atención médica.

C. Los factores psicológicos y conductuales del Criterio B no se explican mejor por otro trastorno mental

Especifique la gravedad actual:

Leve: aumenta el riesgo médico (p. ej., adherencia inconsistente al tratamiento antihipertensivo). Moderado: Agrava la afección médica subyacente (p. ej., ansiedad que agrava el asma).

Severo: resulta en hospitalización médica o visita a la sala de emergencias.

Extremo: Da como resultado un riesgo grave que pone en peligro la vida (p. ej., ignorar los síntomas de un ataque al corazón)

Trastorno facticio

Trastorno ficticio impuesto a uno mismo y Trastorno ficticio impuesto a otro (Anteriormente Trastorno facticio por poder)

A. Falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos, o inducción de lesión o enfermedad, asociada con el engaño identificado.

B. El individuo se presenta a los demás como enfermo, deteriorado o lesionado.

C. El comportamiento engañoso es evidente incluso en ausencia de recompensas externas obvias.

Otro síntoma somático especificado y Trastorno relacionado.

incluyen los siguientes:

1. Trastorno breve de síntomas somáticos: la duración de los síntomas es Menor de 6 meses.
2. Trastorno de ansiedad por enfermedad breve: la duración de los síntomas es menor de 6 meses.
3. Trastorno de ansiedad por enfermedad sin comportamientos excesivos relacionados con la salud o evitación desadaptativa: no se cumple el criterio D para el trastorno de ansiedad por enfermedad.
4. Pseudociesis: Una creencia falsa de estar embarazada que se asocia con signos objetivos y síntomas informados de embarazo.

Síntoma somático no especificado y trastorno relacionados

Esta categoría se aplica a las presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un síntoma somático y un trastorno relacionado que causan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios para ninguno de los trastornos somáticos. Clase diagnóstica de síntomas y trastornos relacionados. La categoría de síntoma somático no especificado y trastorno relacionado no debe utilizarse a menos que existan situaciones decididamente inusuales.



Estadística Nacional

OMS (WHO-AIMS)	Principal motivo de consulta: Detalla que el 33% de los usuarios atendidos en la red ambulatoria nacional corresponden a los trastornos neuróticos, secundarios a situaciones de estrés y de síntomas somáticos	Distribución por sexo: Las mujeres Panameñas representan la mayoría de las consultas ambulatorias globales de salud mental con un 57 % total de las atenciones. 57% del total de las atenciones. Esto coincide con la tendencia global descrita por especialistas de Psychology Today Panamá, quienes señalan que el sexo femenino tiende a reportar y consultar más por síntomas físicos/somáticos que el masculino.
OPS	El Perfil de Salud Mental de Panamá emitido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) clasifica de manera específica el impacto del Trastorno de dolor persistente somatoforme .	Población afectada: Se calcula de forma macro que al menos el 10% de la población de Panamá padece o sufrirá de algún trastorno de salud mental.
Caja de Seguro Social	Comorbilidad elevada: Los trastornos de síntomas somáticos están estrechamente ligados a procesos intensos de ansiedad y depresión .	La Caja de Seguro Social (CSS) y el Centro de Neurociencias reportan que estas dos condiciones encabezan los incrementos de consultas médicas postpandemia, lo cual eleva consecuentemente la probabilidad de manifestar síntomas de somatización.

canva.com - Para salir de la pantalla completa, presione **Esc**

<https://www.paho.org/sites/default/files/2020-09/MentalHealth-profile-2020%20Panama%20esp.pdf>

[https://cdn.who.int/media/docs/default-source/mental-health/who-aims-country-reports/panama_who_aims_report_es.pdf?](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/mental-health/who-aims-country-reports/panama_who_aims_report_es.pdf?sfvrsn=19df712d_3)

<https://www.minsa.gob.pa/informacion-salud/estadisticas-de-salud>



Aspecto	CIE-11: Trastorno de Síntomas Somáticos	DSM-5-TR: Trastorno de Síntomas Somáticos	Similitudes	Diferencias
Definición	Enfocado en la presencia de síntomas somáticos que causan malestar significativo y afectan la vida diaria, con atención excesiva a ellos.	Se centra en síntomas somáticos que causan malestar significativo y preocupación excesiva.	Ambos reconocen síntomas somáticos con impacto significativo y preocupación excesiva.	CIE-11 destaca más el malestar y el efecto en la vida diaria, DSM-5-TR enfatiza la preocupación excesiva.
Criterios Clave	Síntomas somáticos persistentes (más de 6 meses), preocupación y afectación funcional.	Síntomas somáticos que son molestos y generan ansiedad o preocupación desproporcionada.	Persistencia y malestar por síntomas somáticos.	DSM-5-TR incluye criterios específicos sobre pensamiento excesivo relacionado con los síntomas.
Enfoque en la causa	No requiere que los síntomas sean médicamente explicables o no.	Se acepta la posibilidad de que los síntomas tengan o no causa médica clara.	Ambos no exigen causas médicas claras para el diagnóstico.	Similar en este aspecto, aunque DSM-5-TR puede ofrecer un enfoque más clínico detallado.

Duración del Trastorno	Más de 6 meses.	Generalmente más de 6 meses, pero puede diagnosticarse antes si es muy grave.	Duración similar para diagnóstico.	DSM-5-TR puede diagnosticar antes en casos severos.
Comorbilidad	Común con ansiedad y depresión.	También común con trastornos de ansiedad y depresión.	Reconocimiento de comorbilidades similares.	No hay diferencias claras en este punto.
Tratamiento sugerido	Terapia psicológica centrada en manejo de síntomas y estrés.	Terapia cognitivo-conductual y manejo multidisciplinario.	Ambos promueven tratamiento psicológico y multidisciplinario.	DSM-5-TR enfatiza más la TCC como tratamiento.

Resumen sobre el trastorno síntoma somático



Ficha Técnica de la Investigación

Autores principales: Löwe, B., Levenson, J., Depping, M., et al. (2022).

Título: Somatic symptom disorder: A scoping review on the empirical evidence of a new diagnosis.

Revista: Psychological Medicine, 52(4), 632–648.

Objetivo principal: Evaluar de forma integral la validez, fiabilidad y utilidad clínica de los criterios diagnósticos del Trastorno de Síntomas Somáticos (TSS) introducidos por el DSM-5 en 2013, analizando la evidencia científica acumulada durante casi una década.

Metodología y Alcance

El estudio se diseñó como una **revisión exploratoria sistemática** (*scoping review*). Los investigadores aplicaron los siguientes parámetros metodológicos: [National Institutes of Health \(.gov\)](https://www.nih.gov/)

1. **Búsqueda indexada:** Se rastrearon publicaciones en bases de datos de alto impacto como [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/), [PsycINFO](https://psycinfo.org/) y [Cochrane Library](https://www.cochrane.org/).
2. **Filtrado:** Inicialmente se identificaron **882 artículos científicos** relacionados con el TSS publicados entre enero de 2009 y mayo de 2020.
3. **Criterios de inclusión:** Tras una lectura crítica de textos completos, se seleccionaron **59 estudios clave** que cumplieran estrictamente con los estándares empíricos sobre las características diagnósticas, epidemiología y evolución del trastorno.

Famosos que presentan el DX.



Aitana Ocaña

Aitana Ocaña: Ha revelado sufrir hipocondría a un "nivel extremo", un componente clave del trastorno de síntomas somáticos, que le genera ansiedad y preocupación constante por enfermedades físicas.



Céline Dion

Céline Dion: Padece el Síndrome de la Persona Rígida, una enfermedad neurológica que provoca espasmos dolorosos y rigidez, agravada por ansiedad y angustia emocional



Famosos que presentan el DX.



Selena Gómez

Selena Gómez: Desarrolló episodios de ansiedad con manifestaciones físicas graves al lidiar con una enfermedad física (lupus)



Katy Perry

Katy Perry: Ha compartido sus dificultades con la salud mental, que han afectado su bienestar físico.



Resumen sobre el trastorno síntoma somático



Ficha Técnica de la Investigación

Autores principales: Löwe, B., Levenson, J., Depping, M., et al. (2022).

Título: Somatic symptom disorder: A scoping review on the empirical evidence of a new diagnosis.

Revista: Psychological Medicine, 52(4), 632–648.

Objetivo principal: Evaluar de forma integral la validez, fiabilidad y utilidad clínica de los criterios diagnósticos del Trastorno de Síntomas Somáticos (TSS) introducidos por el DSM-5 en 2013, analizando la evidencia científica acumulada durante casi una década.

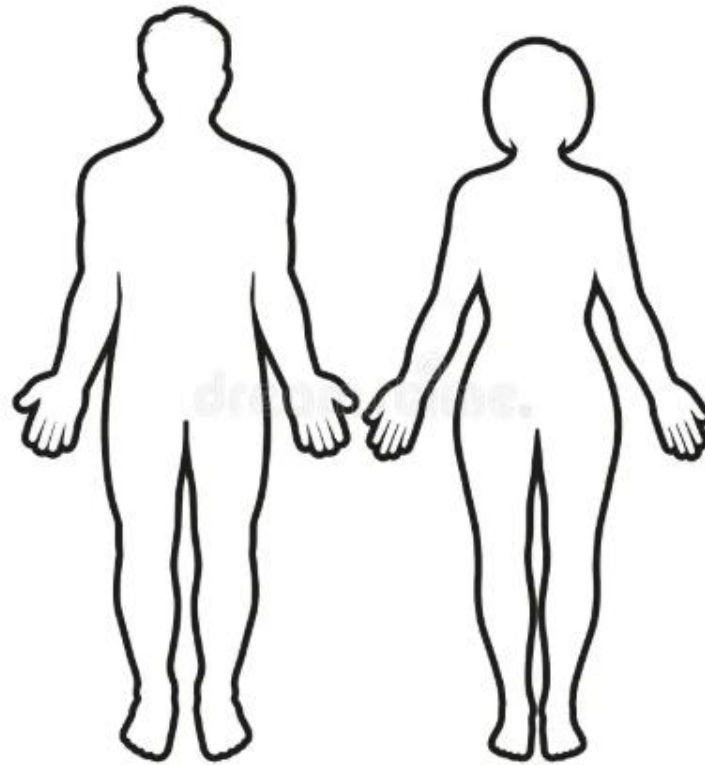
Metodología y Alcance

El estudio se diseñó como una **revisión exploratoria sistemática** (*scoping review*). Los investigadores aplicaron los siguientes parámetros metodológicos: [National Institutes of Health \(.gov\)](https://www.nih.gov/)

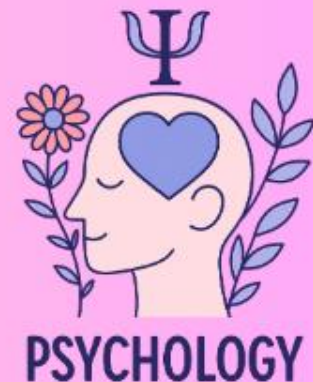
1. **Búsqueda indexada:** Se rastrearon publicaciones en bases de datos de alto impacto como [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/), [PsycINFO](https://psycinfo.org/) y [Cochrane Library](https://www.cochrane.org/).
2. **Filtrado:** Inicialmente se identificaron **882 artículos científicos** relacionados con el TSS publicados entre enero de 2009 y mayo de 2020.
3. **Criterios de inclusión:** Tras una lectura crítica de textos completos, se seleccionaron **59 estudios clave** que cumplieran estrictamente con los estándares empíricos sobre las características diagnósticas, epidemiología y evolución del trastorno.

Dinámica para identificar síntomas somáticos

La silueta Humana



Video



Trastorno de Síntomas Somáticos: Cuando los síntomas físicos te causan ansiedad
Psicología Animada

De un canal con profesional de la salud certificado/a en México

TRASTORNO DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS

Trastornos de Síntomas Somáticos

Mirar en  YouTube

A cartoon illustration of a woman with short black hair, wearing a black dress with a black belt. She has a distressed expression, with her mouth open as if crying or shouting, and her hand on her hip.



Conclusión

Este trastorno nos desafía a reconectar la mente con el cuerpo y a practicar una medicina más empática.

- **Validar:** Escuchar al paciente sin juzgar ni desacreditar su sufrimiento.
- **Integrar:** Unir la medicina física con la salud mental.
- **Educar:** Reducir el estigma social sobre las enfermedades psicosomáticas.
- **Sanar:** Enfocar el éxito en la calidad de vida, no solo en la cura médica.

Reflexión empática (Enfoque humano)

"Los trastornos de síntomas somáticos nos recuerdan que el sufrimiento humano no siempre se puede medir con un análisis de sangre o una radiografía. Cuando el cuerpo habla a través del dolor, la mente a menudo está pidiendo ayuda. Nuestro rol como profesionales de la salud y como sociedad es dejar de buscar simuladores y empezar a escuchar historias, validando que el dolor emocional y el físico comparten el mismo escenario: el ser humano."

Thank You

